

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information - Patient's Copy Liver Resection

معلومات الإقرار – نسخة المريض استئصال الكبد

1. What is a liver resection?

This procedure will involve the removal of part of the liver through a cut in the abdomen.

2. My anaesthetic

This procedure will require an anaesthetic.

See **About Your Anaesthetic information sheet** for information about the anaesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor.

If you have not been given an information sheet, please ask for one.

3. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following:

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

1. ما هو استئصال الكبد؟
في هذا الإجراء تتم إزالة جزء من الكبد من خلال شق جراحي في البطن.

2. الحالة المرضية والعلاج.
سوف يتطلب هذا الإجراء الخضوع للتخدير .
اقرأ تعليمات التخدير المتعلقة بالإجراء الطبي المقرر لك للمزيد من المعلومات عن نوع التخدير والمخاطر المترتبة. إن كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات قم بمناقشتها مع طبيبك المعالج.

إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات ، نرجو عدم التردد في طلبها.

3. ما هي المخاطر المتعلقة بهذا الإجراء بالتحديد ؟
هذا الإجراء له مخاطر ومضاعفات ، وهي تشمل ، ولكنها غير مقصورة على:

مخاطر عامة:

- قد يحدث التهاب ، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى .
- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دايابير دامول (بيرسانتن أو اساسانتين)
- قد يحدث إنسداد للشعب الهوائية الصغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالتهاب في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- عند أصحاب الأوزان الزائدة ، تزداد مخاطر الإصابة بالتهاب الجرح والصدر ، مضاعفات في القلب والرئة ، وجلطات الأوعية الدموية
- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.
- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مم يسبب ألم وتورم في الساق ، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.
- الوفاة محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Specific risks:

- Excessive bleeding from the liver. This may need further surgery and/ or a blood transfusion.
- Bile may leak from the liver cut surfaces and this can cause abdominal pain. Drainage may be necessary.
- Damage to the bile ducts, which could cause long term problems.
- Damage of the bowel which may cause leakage of bowel fluid. This may need further surgery.
- Especially in a male, difficulty in passing urine and a tube may need to be passed into the bladder.
- Infections such as pus collections inside the abdomen. This may need surgical drainage.
- A weakness in the wound with the development, complete or incomplete, bursting of the wound in the short term, or a hernia in the long term.
- Adhesions (bands of scar tissue) may form and cause bowel obstruction. This can be a short term or a long-term complication and may need further surgery.
- The bowel movement may be paralysed or blocked after surgery and this may cause building up of fluid in the bowel with bloating of the abdomen and vomiting. Further treatment may be necessary for this.
- Increased risks in smokers of wound infection, chest infection, heart and lung complications and thrombosis.
- Death in 1 in 100 cases.

Notes to talk to my doctor about:

مخاطر متعلقة بهذا الإجراء:

- نزيف مفرط من الكبد . قد يستدعي ذلك جراحة أخرى وأو نقل دم.
- قد تتسرب المادة الصفراء من أسطح الكبد التي خضعت للجراحة مما قد يسبب ألم في البطن وقد تكون هناك ضرورة لسحبها وتفرغها.
- ضرر قد يصيب القنوات المرارية مما قد يسبب مشاكل لفترات طويلة.
- ضرر للأمعاء مما قد يسبب تسرب لسوائل الأمعاء. قد يتطلب ذلك جراحة أخرى.
- عند المرضى الذكور خاصةً ، قد تكون هناك صعوبة في إدرار البول ، مما قد يتطلب وضع أنبوب (قسطرة بولية) في المثانة.
- الإصابة بالتهاب في سوائل البطن كتجمعات للصدى في التجويف البطني مما قد يتطلب تفريغ الصديد جراحياً .
- ضعف قد يعترى الجرح ويؤدي على المدى القريب إلى تمزقه بشكل جزئي أو كامل ، وعلى المدى البعيد قد يتسبب ذلك في نشوء فتق. قد يتطلب ذلك جراحة أخرى.
- قد تحدث التصاقات (أحزمة من الأنسجة المتندبة) وتسبب انسداداً للأمعاء. قد يحدث ذلك على المدى القريب أو البعيد وقد يحتاج حلاً جراحياً.
- قد تصاب حركة الأمعاء بالانسداد وببطء الحركة بعد العملية مما يسبب تراكم السوائل في الأمعاء وانتفاخ للبطن وتقيؤ. قد يتطلب الأمر علاج آخر.
- عند المدخنين تزداد عدوى الجرح والصدر ومضاعفات القلب والرئة والتخثرات الدموية.
- حدوث الوفاة في 1 من كل 100 مريض.

أمر أتناقش حولها مع طبيبي:
